

Fecha Última Actualización: 19-02-2022 11:40:14

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Carlos Alfonso Bravo Abarca
Edad : 29a 2m 1d
Dirección : Comuna De San Antonio

Rut : 18.364.959-0
Fecha Nacto: 18/12/1992
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1228626
Sexo : Masculino
Teléfono : 947466330

N° Epicrisis
296266

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 07/02/2022 11:19

Días Estadía: 12

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 19/02/2022 11:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES:

- Mórbidos: (-)
- Quirúrgicos: (-)
- Fármacos: (-)
- Alergias: (-)
- Hábitos: OH (+), Simpaticomiméticos (+), Pasta base (+)
- Inmunizaciones: 1era y 2da dosis COVID-19.

ANAMNESIS:

Paciente traído por SAMU por compromiso de conciencia.

Aparentemente vecino lo encuentra a las 09:00 am con lesiones producidas por arma blanca (destornillador) en hemitórax derecho, ojo derecho y cráneo.

Ingresó con conciencia fluctuante entre soporoso y agresivo. Sin emitir lenguaje ni obedecer órdenes. Con regular control de vía aérea.

Se evidenció hematoma en ojo derecho y pupila ipsilateral arrefléctica. Movilizando 4 extremidades. Se realizó protocolo E-FAST que resultó negativo.

Se tomó TAC de cerebro (07/02), poco evaluable por artefacto de movimiento pero sin grandes lesiones evidentes.

TAC de tórax con infiltrado alveolar bilateral que pudiese ser edema alveolar vs SDRA según informe preliminar.

Laboratorio de ingreso destacó Leucocitosis de 17.000 y CK en 640. Resto sin alteraciones significativas.

Evolucionó con mayor compromiso de conciencia, pérdida de protección de vía aérea, desaturación y mala mecánica por lo que se intubó 07/02.

Se controló TAC de cerebro 09/02 con sedoanalgesia en donde se observa lesión hemática traumática a nivel de cerebelo izquierdo e hiperdensidad traumática a nivel tentorial. Cisternas basales y surcos de convexidad presentes.

Evaluable por neurocirugía sugiere carga con fenitoína y mantener medidas de neuroprotección.

Ingresó a UCI para continuar manejo y seguimiento.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

Fecha Epicrisis : 19/02/2022 11:40

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 19-02-2022 11:40:14

Página 2 de 3

1. TEC Grave Complicado
 - Contusión hemorrágica cerebelar izquierda
 - HSA traumática
2. Neumonía Aspirativa
3. Trastorno por abuso de sustancias

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS:

- 1) Hemodinámico: al ingreso requerimientos de NAD hasta 0.6, suspende precozmente. Luego estable, sin conflicto.
- 2) Neuroquirúrgico: ingresa con TEC complicado en fase aguda. TAC de ingreso 07/02 que evidencia trayecto hemorrágico hemipontino y en hemisferio izquierdo. Evaluado por neurocirugía, sin indicación quirúrgica. Recibe carga de fenitoína x7 días profiláctica. Control de lesión con RNM, que muestra alteraciones esperables secundarias a trauma, que no requieren mayor intervención. Queda con plan de rehabilitación motora por contusión cerebelosa en APS.
- 3) Ventilatorio: IOT 07/02 por mal control de vía aérea, con buen intercambio gaseoso. Extubado 11/02, weaning ok, al alta sin O2 suplementario.
- 4) Infeccioso: cursa con NAVM por KPN MS, tratada con ampicilina sulbactam por 7 días, con buena respuesta. Al alta sin ATB.
- 5) Psiquiátrico: consumo importante de sustancias. Evaluado por psiquiatría, se indican BDZ en dosis decrecientes. Al alta con clonazepam VO en plan de suspensión durante 14 días. IC a COSAM, entrego documento.
- 6) Oftalmológico: Evaluado por oftalmología por trauma ocular contuso ojo derecho. Unguento CAF en fondo de saco inferior OD. Evaluado pre alta, se indica prednisona 40 mg al día por 5 días (iniciado el 18/02) y control durante la próxima semana (21 al 25 de febrero) en policlínico de neurooftalmología en CDT.
- 7) Rehabilitación: progresa régimen post IOT en seguimiento por FNA. Al alta sin restricción de consistencias.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

TEC Grave Complicado

- o Contusión hemorrágica cerebelosa izquierda
- o HSA traumática

Neumonía Aspirativa

- o K pneumoniae MS tratada con Amp/Sulb 7d

Trastorno por abuso de sustancias

Delirium mixto

Diagnóstico de Egreso

Traumatismos Múltiples, No Especificados -
Neumonía Asociada a Cuidados de la Salud: NAVM -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en BCG, HD estable, afebril, sin req de O2 suplementario. Tranquilo, sin episodios de agitación. Sin requerimiento de lorazepam SOS

Plan Post Alta

1. Reposo relativo
2. Régimen común. Tomar agua al final de la comida.
3. Medicamentos:
 - Clonazepam 2 mg comprimidos. Tomar 1 comprimido en la noche x 7 días VO. Luego, tomar medio comprimido en la noche x 7 días VO. Luego, suspender medicamento.
 - Cloranfenicol colirio 1 gota/ojo c/6 h
4. Controles:
 - Neurológico: asistir de forma ambulatoria a CESFAM o CRS para rehabilitación de la marcha. Llevar epicrisis y solicitar kinesioterapia para rehabilitación de la marcha con este documento.
 - Psiquiatría: llevar interconsulta realizada (entrego documento) a su CESFAM para hacer derivación a nivel secundario para atención por trastornos por consumos de múltiples sustancias.
 - Oftalmología: control en CDT de Hospital Sotero del Río con durante la próxima semana (del 21 a 25 de febrero) en policlínico de neurooftalmología. Pedir hora con epicrisis.
5. Volver al servicio de urgencias en caso de fiebre, dolor al pecho, dificultad para respirar, dificultad para hablar o mover alguna extremidad, compromiso de conciencia, o en caso de considerarlo necesario.

Fecha Epicrisis : 19/02/2022 11:40

Página 2 de 3

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Blanco Sin Residuos

Medicamentos : Quetiapina 25 Mg 1 Comprimido En La Noche Oral
Prednisona 20 Mg 2 Comprimidos Al Día (En La Mañana) Oral Por 5 Días
Paracetamol 500mg 2 Comprimidos Cada 8 Horas Oral Sos Si Dolor
Omeprazol 20mg 1 Cápsula En Ayunas Oral
Cloranfenicol Oft. 0.5%/10ml Colirio 1 Gora Cada 6 Hrs En Ojo Derecho Hasta Control Por Oftalmología
Clonazepam 2 Mg 1 Comprimido En La Noche X 7 Días, Luego 1/2 Comp En La Noche Por 7 Días

Controles

S/F - CDT - Oftalmología - Control durante semana del 21-25 de febrero con neurooftalmología (pasillo 10 CDT)

S/F - APS - - Llevar interconsulta entregada por Psiquiatría a CESFAM por trastorno de uso de sustancias

S/F - APS - - Realizar kinesiterapia de rehabilitación de la marcha (pedir hora con epicrisis).



Gonzalo Enrique Moya Gallo

Becado/Residente

INTERNO



Paula Arriagada San Martín

Médico Tratante (Staff)